



Un germe inhabituel incriminé aux infections liées aux cathéters tunnésés d'hémodialyse (A propos de trois cas)

A. BEGRICHE (asma_hanene@live.fr)
W.Messai, L.KRIBECHE, S.Talbi, Z.Maiza, I.BENHARKAT, H.KHELOUFI
Service de Néphrologie et Hémodialyse –CHU de Sétif-
Service d'hémodialyse - EPH El Eulma –Sétif-

Introduction:

Les infections représentent la deuxième cause de mortalité chez les hémodialisés chroniques après les complications cardiovasculaires. Ces infections sont majoritairement liées à l'accès vasculaire et plus particulièrement aux cathéters centraux. Les agents pathogènes responsables les plus courants sont les bactéries gram positives, *Staphylococcus aureus* et les staphylocoques à coagulase négative puis viennent les organismes Gram-négatifs, tandis que les infections polymicrobiennes et les infections fongiques sont moins fréquentes. *Stenotrophomonas maltophilia* est un bacille gram négatif lié exclusivement aux soins, très rarement isolé en hémodialyse; de prise en charge difficile car il menace le pronostic fonctionnel de l'abord vasculaire et parfois vital du patient.

Matériel et méthode:

Il s'agit de 3 malades hémodialisées chroniques dans la même clinique d'hémodialyse âgées respectivement de 69 ans, 52 ans et 62 ans. Les trois patientes étaient porteuses de cathéters tunnésés au niveau de la veine jugulaire droite; hospitalisées au service de néphrologie pour la prise en charge d'une infection de leurs cathéters. Nous décrivons la présentation clinique, les données biologiques, microbiologiques ainsi que la prise en charge thérapeutique.

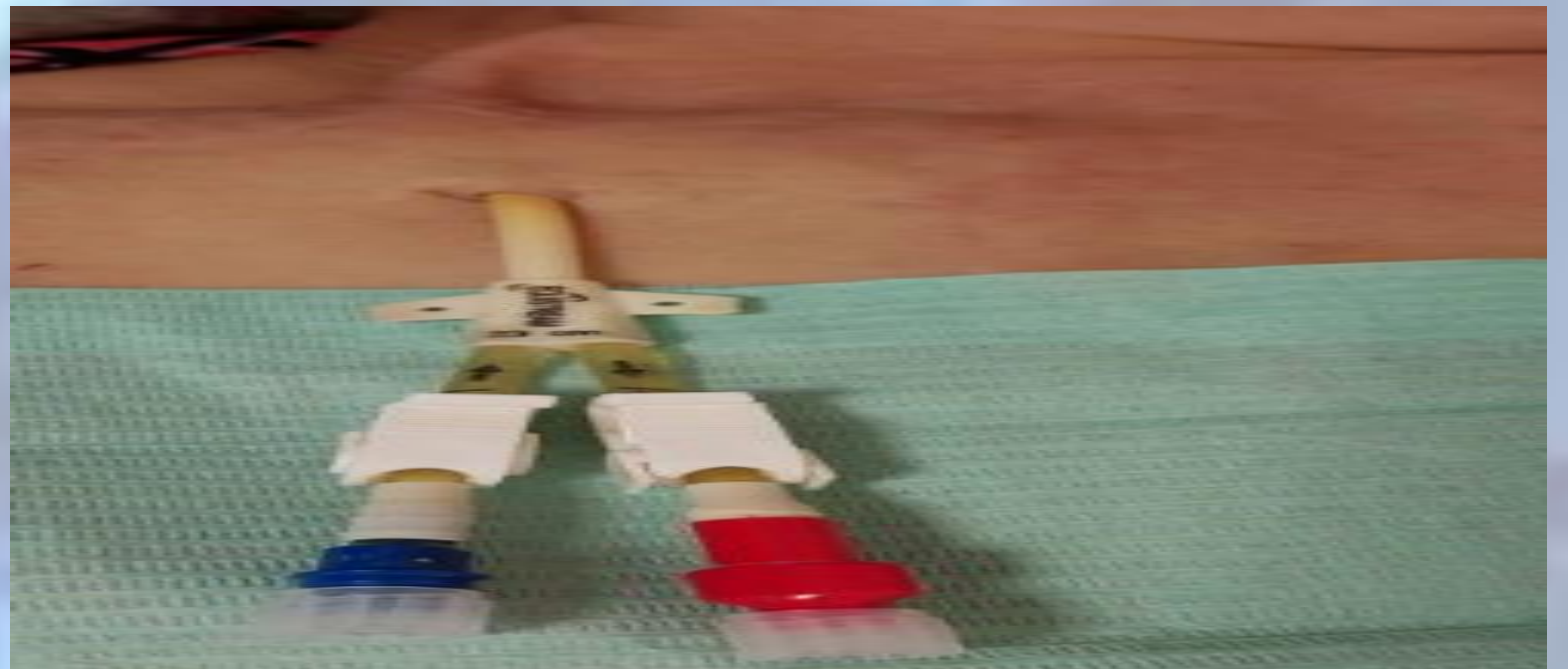
Résultats:

Sur le plan clinique, les trois patientes présentaient une fièvre entre 38.5 et 40 degrés avec notion de frissons en per dialyse une semaine avant leur hospitalisation.

Sur le plan biologique :

- Malade 1 : GB : 13.000 éléments/mm³ .CRP : 119 mg/l
- Malade 2 : GB : 16.000 éléments/mm³ .CRP : 118 mg/l
- Malade 3 : GB : 18.000 éléments/mm³ .CRP : 95 mg/l

L'hémoculture périphérique et la culture prélevée de l'extrémité du cathéter objectivent le même germe chez les trois patientes «*Stenotrophomonas maltophilia* ». Une antibiothérapie à base de colistine et bactrim basée sur l'antibiogramme a été administrée avec gentamicine en verrou. Devant la non amélioration une ablation des cathéters était indiquée avec une bonne évolution clinico-biologique.



Discussion:

L'hémodialyse est une méthode d'épuration extrarénale qui nécessite un accès vasculaire, la fistule artério-veineuse étant l'abord vasculaire idéal chez les insuffisants rénaux chroniques au stade terminal; elle n'est pas toujours réalisable et nécessite plusieurs semaines de maturation. L'alternative est le cathéter tunnésé utilisé immédiatement.

Cependant, il est responsable de complications préjudiciables en termes de morbi-mortalité. L'infection est la complication la plus fréquente et la plus grave. Les directives KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) classent ces complications infectieuses en plusieurs catégories précises :

*Infection de l'émergence ou du site de sortie (Exit-site infection) *tunnelite (Tunnel infection) ***Bactériémie liée au cathéter (CRBSI - Catheter-Related Bloodstream Infection)** : Association de manifestations cliniques (comme la fièvre ou les frissons) avec au moins une hémoculture positive sans autre source apparente d'infection. Une culture positive pour le même germe prélevée au niveau de l'extrémité du cathéter. C'est le cas de nos patientes.

Les complications infectieuses métastatiques des CRBSI comprennent l'endocardite, l'ostéomyélite, l'abcès épidual rachidien, l'arthrite septique, l'abcès cérébral et l'embolie pulmonaire septique.

Deux voies principales de contamination ont été distinguées :

- La voie extraluminale : les micro-organismes de la flore cutanée du patient (ou des mains du personnel soignant) colonisent la surface externe du cathéter et migrent à partir du site d'insertion cutanée le long du trajet sous-cutané du cathéter.
- La voie endoluminale: Les micro-organismes colonisent la surface interne du cathéter. Plus rarement; par voie hématogène à partir d'un autre foyer infectieux distant ou bien par contamination du liquide de perfusion.

Le *Stenotrophomonas maltophilia* (Sm) est l'archétype de la bactérie environnementale opportuniste. Il est à l'origine d'infections associées aux soins (IAS) sur un mode aigu chez le patient immunodéprimé porteur de dispositif invasif (bactériémie sur cathéter, pneumopathie acquise sous ventilation chez le patient intubé ventilé) ou chronique chez le patient atteint de mucoviscidose. Il s'agit d'un bacille à Gram négatif aérobique obligatoire non fermentant qui a la forme d'un bâtonnet et qui est mobile avec quelques flagelles polaires; caractérisé par sa capacité à persister dans les réseaux de plomberie et sur les surfaces humides par sa versatilité métabolique et par sa résistance naturelle aux antibiotiques, et notamment aux carbapénèmes.

Conclusion :

Les infections des abords vasculaires d'hémodialyse constituent une cause majeure de morbi-mortalité. Le *Stenotrophomonas maltophilia* est un germe peu connu, une fois isolé; la prise en charge est très difficile nécessitant parfois l'ablation du dernier abord vasculaire. L'identification des voies de contamination par des prélèvements d'environnement ou des typages moléculaires permet de mettre en place les mesures adaptées : renforcement de la lutte contre la transmission croisée, filtres terminaux, décontamination de l'environnement et le bon usage des antibiotiques. Une asepsie rigoureuse demeure la pierre angulaire de la prévention.